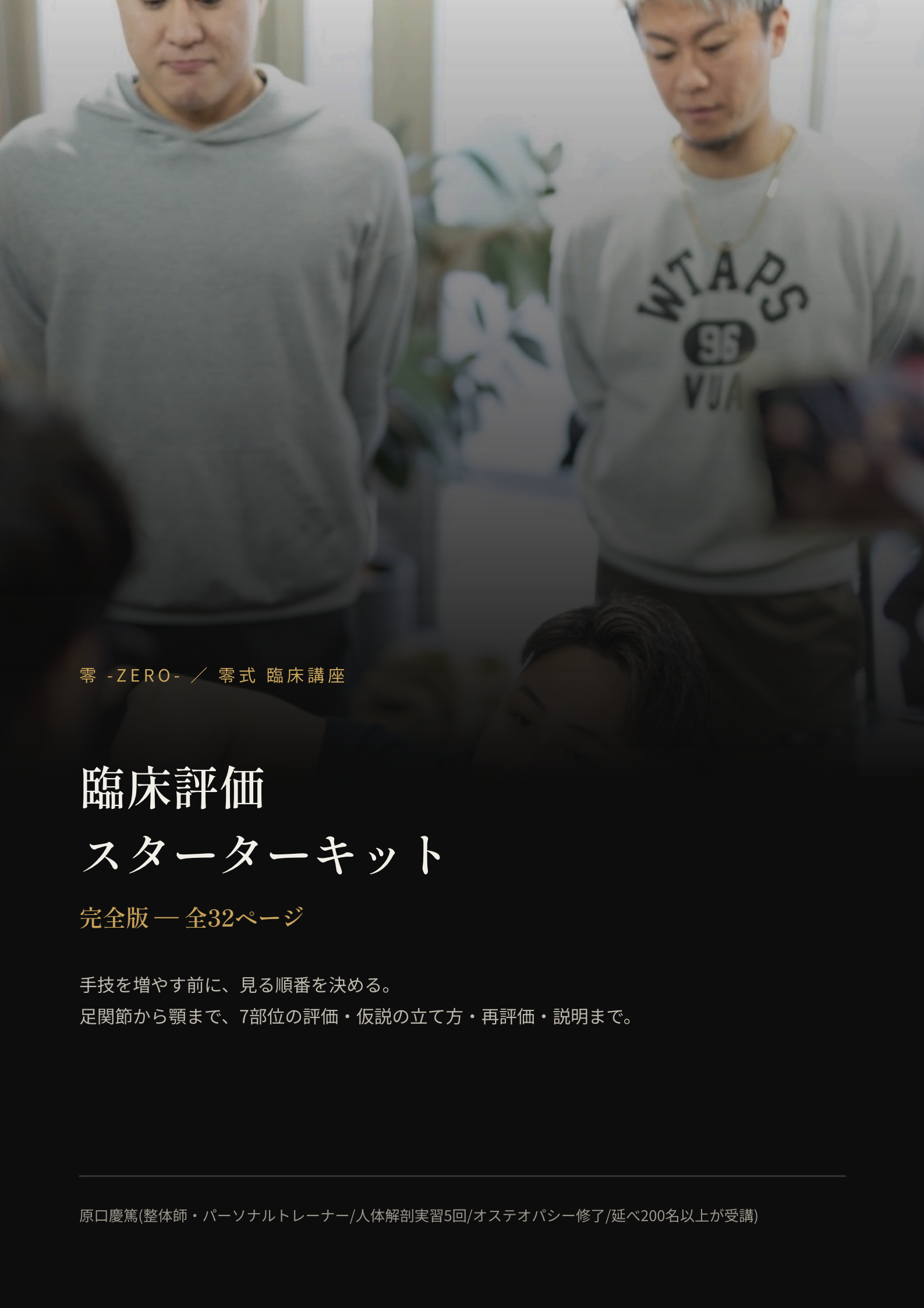




零 -ZERO- / 零式 臨床講座

臨床評価 スターターキット

完全版 — 全32ページ

手技を増やす前に、見る順番を決める。

足関節から顎まで、7部位の評価・仮説の立て方・再評価・説明まで。

目次

このキットは、初回の評価を**毎回同じ順番で、同じ条件で**行うための教科書です。前から順に読んでも、必要な部位だけ開いても使えます。

はじめに

なぜ「施術しても戻る」のか	p.3
零式の基本:評価→選択→再評価	p.4
評価の前に:レッドフラッグと連携	p.5

評価の土台

最初の5分:問診で聞くこと	p.6
姿勢観察:前・横・後ろ	p.7
動作スクリーニング5つ	p.8
記録のルール:同じ条件で測る	p.9
7部位マップと評価の順番	p.10

部位別の評価(各2ページ)

① 足関節	p.11
② 足部・歩行	p.13
③ 膝・股関節	p.15
④ 骨盤・腰部	p.17
⑤ 胸郭・呼吸	p.19
⑥ 肩甲帯・頸部	p.21
⑦ 顎・頭部	p.23

評価をつなげる

よくある連鎖パターン	p.25
仮説の立て方	p.26
記入例1 戻る肩こり	p.27
記入例2 膝の内側の痛み	p.28
記入例3 前屈で張る腰	p.29

現場で使う

再評価とクライアントへの説明	p.30
評価シート(印刷用)	p.31
特典動画と次のステップ	p.32

なぜ「施術しても戻る」のか

その場では変わるのに、次に来たときには元に戻っている — 多くの施術者が一度は抱える悩みです。手技の上手い下手より先に、次の3つを疑ってみてください。

① 痛い場所=原因、と決めている

首がこる人の首を緩める。膝が痛い人の膝を見る。もちろん大切ですが、痛む場所は「頑張らされている場所」であることも少なくありません。上下の関節が動いていないと、また同じ場所に負担が集まります。

② 評価の順番が毎回ちがう

その日の気分や、クライアントの訴えに引っぱられて、見る場所が毎回変わる。これでは前回との比較ができず、何が効いたのかも分かりません。

③ 再評価をしていない

施術のあとに「どうですか?」と聞くだけで終わる。主観の「楽になった」は大切な情報ですが、それだけでは変化の理由が分かりません。同じテストを、同じ条件で、もう一度行うことで、初めて仮説が確かめられます。

このキットのゴール

手技を1つ増やすより、「何を・どの順番で・どう確かめるか」を決める。それだけで、同じ手技の結果が変わります。

零式の基本:評価 → 選択 → 再評価

変わらなければ、仮説を切り替えて評価へ戻る



零式では、型を当てはめる前に**評価して、選んで、確かめる**ことを大切にします。身体は本来、自分で整う力を持っています。私たちの役割は、何かを足すことより、その力が働きにくくなっている理由を見つけることです。

段階	やること	ポイント
評価	問診・姿勢・動作・部位別テスト	数値か、左右差か、動作の質で記録する
選択	仮説を1〜2個に絞り、アプローチを選ぶ	一度に全部やらない。何が効いたか分からなくなる
再評価	同じテストを同じ条件で行う	変わらなければ仮説を切り替える。失敗ではなく情報

「構造・神経・流れ」の3つの目

構造:関節の動き、筋の長さ、骨の位置

神経:力の入り方・抜け方、呼吸、緊張の高さ

流れ:体液・循環、動作の中での力の伝わり方

どれか1つに偏らず、3つの目で同じ身体を見ることで、仮説の精度が上がります。

評価の前に:レッドフラッグと連携

評価を始める前に、**施術の対象かどうか**を確認します。下の項目がある場合は、評価や施術を続けず、医療機関につなぎます。

すぐに救急(119)

- 突然の胸の痛み、強い息苦しさ
- これまでで一番ひどい、突然の激しい頭痛
- 新しく出た排尿・排便の障害、股のまわり(会陰部)の感覚の低下
- だんだん強くなる手足の脱力、ろれつが回らない、顔のゆがみ
- 急な片脚の腫れ・痛み・熱感に、胸の痛みや息苦しさをともなう

早めの受診をすすめる

- 安静時・夜間にも強い痛みがある/日に日に強くなる
- しびれ・感覚の低下・力の入りにくさがある
- 外傷(転倒・事故)の直後、骨折の疑い
- 発熱、原因の分からない体重減少、がんの既往
- 急な片脚の腫れ・痛み・熱感(血栓の可能性)
- 顎の痛みや開口障害が続く(歯科・口腔外科へ)

伝え方の例

「今日の評価で、私の施術の範囲を超えている可能性があるサインが見つかりました。まず〇〇科で一度診てもらってください。問題がなければ、そのあとで一緒に進めましょう。」

— 不安をあおらず、理由と次の行動をセットで伝えます。

※ここに挙げたものはすべてではありません。迷ったら、施術せずに医療機関への相談をすすめてください。

最初の5分:問診で聞くこと

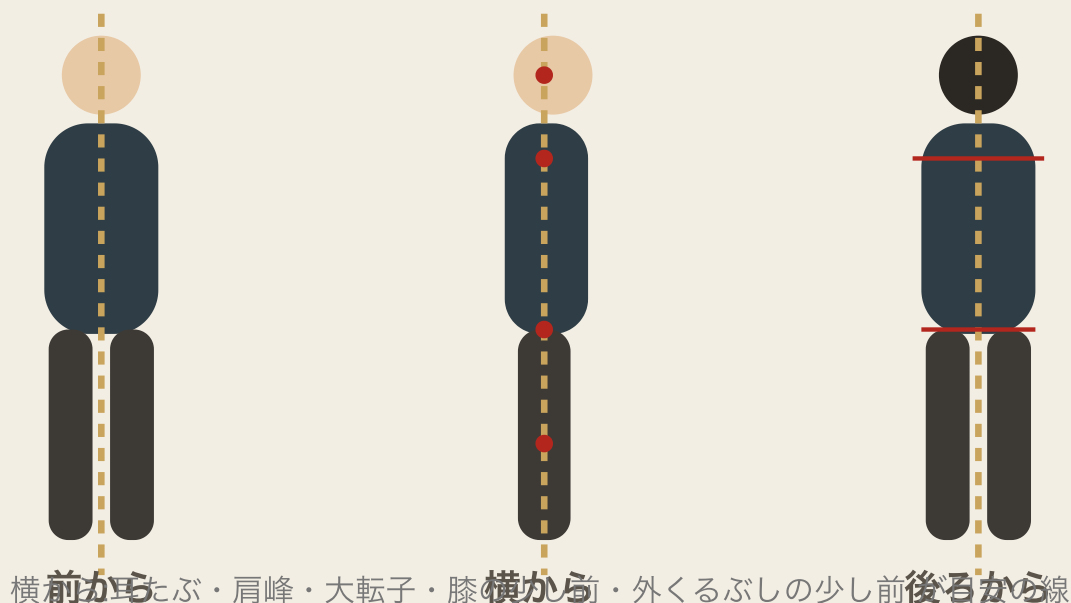
問診は「情報を集める」だけでなく、**どの部位から評価するか**を決める時間です。以下の順で聞くと、5分でまとまります。

聞くこと	質問の例	評価へのつなげ方
① いちばん困っていること	「今日いちばん何とかしたいのはどこですか?」	主訴を1つに絞る。複数あれば優先順位をつけてもらう
② いつから・きっかけ	「いつから?何かきっかけはありましたか?」	急に始まった/外傷あり → レッドフラッグを再確認
③ どんなときに出るか	「朝?夕方?座ると?歩くと?」	出る動作=評価で再現する動作。必ずメモする
④ 楽になるとき	「どうすると楽になりますか?」	楽になる姿勢は、仮説のヒントになる
⑤ 過去のケガ・手術	「昔の捻挫や骨折は?」	足首の古い捻挫は、上の関節に影響を残していることがある
⑥ 生活と運動	「お仕事の姿勢は?運動は?」	1日の中で一番長い姿勢を把握する
⑦ ゴール	「楽になったら何をしたいですか?」	再評価で確かめる動作を一緒に決める

問診のコツ

- 主訴の強さは0～10で聞いて記録する(NRS)
- 「出る動作」を必ず1つ決めて、評価の最初と最後に同じ動作をしてもらう
- 聞きながら、立ち方・座り方・呼吸を観察しておく

姿勢観察:前・横・後ろ



方向	見るポイント	メモの例
前から	頭の傾き/肩の高さ/骨盤の高さ/膝とつま先の向き/体重がどちらの足に乗っているか	右肩↓、右膝が内向き、左荷重
横から	頭の位置(前方か)/胸の丸まり/骨盤の前傾・後傾/膝の過伸展/重心が前か後ろか	頭部前方、胸椎後弯↑、膝過伸展
後ろから	肩甲骨の高さ・浮き/背骨の側弯/骨盤の高さ/アキレス腱と踵骨の傾き	右肩甲骨の浮き、左踵骨外反

観察の注意点

- 姿勢は「良い・悪い」ではなく**左右差と、その人の普段との差**を記録する
- 静止姿勢だけで原因を決めない。次の動作スクリーニングと合わせて判断する
- 写真を撮る場合は、同じ距離・同じ高さ・同じ立ち位置で(同意を得てから)

動作スクリーニング5つ

部位別の評価に入る前に、全身の動きを5つだけ見ます。どこで動きが止まるか・左右差があるかで、詳しく見る部位を絞ります。

動作	やり方	よく見られる所見	詳しく見る部位
① 立位前屈	膝を伸ばしたまま、ゆっくり前へ	腰だけが丸まる/股関節が曲がらない/手の位置の左右差	③④
② 立位後屈	手を腰に当てて、ゆっくり後ろへ	腰の一か所で折れる/胸が開かない	④⑤
③ スクワット	足は肩幅、腕は前へ、できる深さまで	踵が浮く/膝が内に入る/体幹が大きく前に倒れる	①③
④ 片脚立ち	30秒を目安に、左右	骨盤が下がる/足部が大きく揺れる/左右差	①②③
⑤ 腕の挙上	両腕を前から上へ、ゆっくり	肩がすくむ/腰を反らせて代償する/左右差	⑤⑥

記録の仕方

各動作を「○ 問題なし/△ 左右差・代償あり/× 痛みあり」の3段階でつけます。×(痛みあり)の動作は、強く繰り返さないこと。痛みを再現する動作は、再評価の指標として使います。

ここでの目的

スクリーニングは診断ではありません。「どの部位から詳しく見るか」を決めるための地図です。△や×がついた動作に関係する部位から、11ページ以降の部位別評価に進みます。

記録のルール:同じ条件で測る

再評価で比べるためには、**最初と同じ条件で測る**ことが欠かせません。条件がずれると、変化したのか、測り方が変わったのか区別できません。

指標	単位	条件をそろえるポイント
痛みの強さ	0～10(NRS)	「同じ動作をしたときの痛み」で聞く。安静時と動作時を分ける
関節の角度	度(°)	開始姿勢・基準線・ゴニオメーターの当て方を毎回同じにする
距離	cm・mm	起点(つま先・指先など)と、測る相手(壁・床)を決めておく
回数・時間	回・秒	休憩の有無、測る前の姿勢(座位で1分休むなど)を決める
呼吸数	回/分	安静座位で1分休んでから、1分間数える。運動直後は測らない
動作の質	○△×+メモ	同じ方向・同じ距離から観察する。可能なら動画で比べる

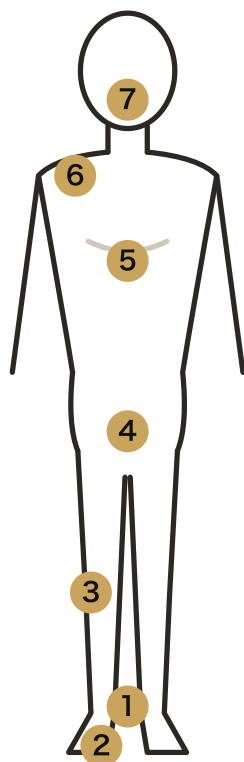
良い記録・悪い記録

悪い例:「足首が硬い」「肩が上がりにくい」

良い例:「Knee to Wall:右6cm/左10cm(母趾先端～壁、踵接地、膝は第2趾方向)」
「拳上:右140°で肩がすくむ、NRS 4」

数字と条件があれば、次回の自分にも、他の施術者にも伝わります。

7部位マップと評価の順番



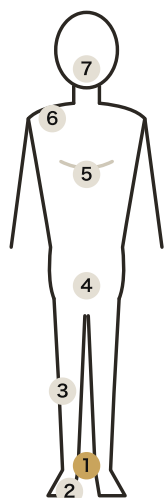
評価は下から上へ進めます。地面に近い部位の問題は、その上のすべての部位に影響しやすいからです。

番号	部位	主な役割
1	足関節	衝撃吸収と前への移動
2	足部・歩行	柔らかい足と硬い足の切り替え
3	膝・股関節	体重を支え、方向を変える
4	骨盤・腰部	上半身と下半身の力の通り道
5	胸郭・呼吸	呼吸と、肩甲骨・頭の土台
6	肩甲骨・頸部	腕の動きと頭の位置を支える
7	顎・頭部	頭の位置・舌・呼吸と関わる

全部を毎回見なくてよい

問診と動作スクリーニングで気になった部位を中心に、**その部位と上下1つずつ**を見るのが基本です。たとえば肩こりなら⑥を中心に、⑤と⑦、さらに土台として①②も確認します。慣れてきたら、初回は7部位すべてを通して見ると、その人の「地図」ができます。

① 足関節:なぜ見るか



荷重時の衝撃吸収と、前への移動を担う関節。距腿関節の背屈が不足すると、膝・股関節・腰が代わりに動いて帳尻を合わせます。

押さえない解剖

- 距腿関節:脛骨・腓骨と距骨でできる関節。背屈・底屈の主な動き
- 距骨下関節:踵骨の内・外への傾きに関わり、足部の柔らかさを調整
- 下腿三頭筋・アキレス腱:背屈を制限しやすい代表。ただし「硬い=ふくらはぎ」とは限らない
- 古い捻挫:距骨の動きや感覚に影響が残ることがある

よくある代償の流れ

- 背屈不足 → しゃがむと踵が浮く/膝が内に入る/体幹が前に倒れる
- 歩行で蹴り出しが早く終わり、股関節の伸展が不足する

クライアントに当てはまるか、まず3つ確認

確認すること	はい
しゃがむと踵が浮く?	☐
片側だけ足首を捻挫したことがある?	☐
階段の下りで膝や腰に負担を感じる?	☐

原口の臨床メモ

足首は「全身の一番下の歯車」。ここが噛み合わないと、上の歯車はすべて余計に回ります。肩こりの相談でも、私は最初に足首を見ます。

① 足関節:どう見るか

テスト	開始姿勢	測り方	見るポイント
Knee to Wall	立位。踵を床につけたまま、膝を第2趾の方向へ壁につける	膝が壁につく最大距離を、母趾先端～壁で測る(cm)	左右差、痛み・つまり感の場所(前か後ろか)
非荷重の背屈	長座位または背臥位、膝伸展位と膝屈曲位の両方	ゴニオメーターで角度(°)	膝伸展で減る → 腓腹筋の関与。両方で減る → 関節やヒラメ筋も確認
踵骨の向き	立位、後方から	アキレス腱と踵骨の線の傾き	左右差。片脚立ちで変化するか
背屈時の距骨の後方滑り	背臥位、膝屈曲位。脛骨を固定して距骨を後方へ	動きの量と終わりの感覚を左右で比べる	動きが少ない側は、関節の可動性も候補に

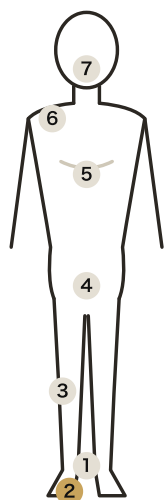
解釈のヒント

前側がつまる感じ → 関節や前方組織の関与を疑う/後ろが張る感じ → 下腿後面の柔軟性を疑う。
ただし1つのテストで決めず、組み合わせて判断します。

よくある誤り

- 「硬い=ふくらはぎ」と決めてストレッチだけ続ける
- 荷重と非荷重を比べずに判断する(測定条件が違うので、差は手がかりの1つとして扱う)
- 強い痛みや腫れが続く足首を、評価せずに動かし続ける

② 足部・歩行:なぜ見るか



足部は、着地では柔らかく衝撃を吸収し、蹴り出しでは硬いてこになります。この切り替えがうまくいかないと、上の関節が代わりに働きます。

押さえて解剖

- 内側縦アーチ:荷重で少し下がり、蹴り出しで戻るのが自然な動き
- 母趾(第1中足趾節関節):蹴り出しで伸展が必要。制限があると外側へ逃げる
- 後脛骨筋・足底の筋:アーチを支え、着地の速さを調整
- 足裏の感覚:立ち方・バランスの情報源

よくある代償の流れ

- 着地で足部が大きく内に倒れ続ける → 膝が内に入りやすい
- 母趾で押せない → 外側で蹴る → 骨盤の左右の揺れが大きくなる

クライアントに当てはまるか、まず3つ確認

確認すること	はい
靴の減り方に左右差がある?	☐
裸足で片脚立ちをすると大きく揺れる?	☐
歩くと骨盤が左右に大きく揺れる?	☐

原口の臨床メモ

足裏は「センサー」でもあります。形を変えるより、地面を感じて押せる足に戻すことが先です。

② 足部・歩行:どう見るか

テスト	開始姿勢	測り方	見るポイント
歩行観察	5～10mを普段の速さで。 前・横・後ろから	踵接地→足底接地→蹴り出しの流れを見る	倒れ込みの速さ、蹴り出しの位置、左右差
母趾の伸展	座位または立位	母趾を反らせる角度と、終わりの感覚	左右差。歩行の蹴り出しと一致するか
ナビキュラードロップ	座位→立位で舟状骨の高さを比べる	高さの差(mm)	差が大きい側は、アーチの支えを確認
片脚立ちでの足部	片脚立ち30秒	足指の力み、アーチの崩れ、揺れの大きさ	左右差。目を閉じると大きく変わるか

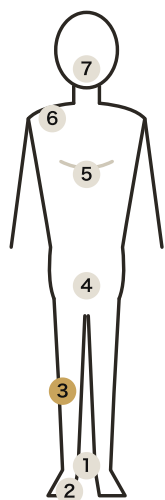
解釈のヒント

平らな足=悪い、ではありません。大切なのは「動きの切り替えができていないか」です。静止の形より、動いたときの変化を見ます。

よくある誤り

- インソールや足底の形だけで判断する
- 歩行を見ずに、立位の形だけで結論を出す
- 上半身から整えて「歩くと戻る」を繰り返す

③ 膝・股関節:なぜ見るか



膝は、股関節と足関節の「間」にあり、上下の動きに振り回されやすい関節です。膝の痛みは、股関節や足関節の動きと一緒に見ます。

押さえない解剖

- **股関節:**球関節で、屈曲・伸展・内外旋の大きな動きを持つ
- **中殿筋:**片脚立ちで骨盤を水平に保つ
- **膝関節:**主に曲げ伸ばし。ねじれには上下の関節の影響が大きい
- **大腿四頭筋・ハムストリングス:**膝と股関節の両方をまたぐ筋

よくある代償の流れ

- 股関節の動きが少ない → 膝のねじれや腰の動きで代償
- 足関節の背屈不足 → スクワットで膝が内に入る

クライアントに当てはまるか、まず3つ確認

確認すること	はい
スクワットで膝が内に入る?	☐
あぐらや脚を組む動きに左右差がある?	☐
片脚立ちで反対の骨盤が下がる?	☐

原口の臨床メモ

膝は「被害者」になりやすい関節。膝を責める前に、上の股関節と下の足首に話を聞きにいけます。

③ 膝・股関節:どう見るか

テスト	開始姿勢	測り方	見るポイント
スクワットの膝の向き	足は肩幅、つま先はやや外	膝が第2趾の方向に向くか	内に入る → 股関節・足関節・体幹をそれぞれ確認
股関節の内旋・外旋	腹臥位または座位、股関節90°屈曲位	角度(°)と左右差、終わりの感覚	片側だけ少ない → その側の股関節を詳しく
片脚立ちの骨盤	片脚立ち30秒、後方から	反対側の骨盤が下がるか	下がる → 中殿筋の働きや足部の安定を確認
片脚スクワット	浅く5回	膝の向き、骨盤・体幹の傾き	両脚スクワットとの違いを見る

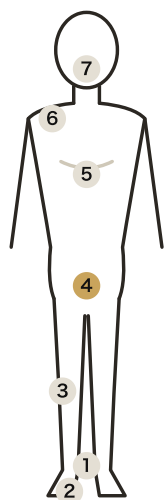
解釈のヒント

膝が内に入る動きには、股関節・足関節・体幹・痛みの回避など、いくつかの理由があり得ます。1つの所見から原因を決めず、複数のテストを組み合わせます。

よくある誤り

- 膝が痛い=膝だけを見る
- 「内股だから」で説明を終える
- 腫れや熱感のある膝に、強い負荷のテストを行う

④ 骨盤・腰部:なぜ見るか



骨盤と腰は、上半身と下半身の力の通り道です。ここで動きが止まる場所があると、その上下に負担が集まります。

押さえてたい解剖

- 腰椎:曲げ伸ばしが中心で、ねじれの動きは小さい
- 仙腸関節:わずかな動きで、力の伝達を助ける
- 股関節屈筋・ハムストリングス:骨盤の傾きに影響する
- 腹部と背部の筋:体幹を支え、呼吸とも関わる

よくある代償の流れ

- 股関節が曲がらない → 前屈で腰だけが丸まる
- 胸椎が伸びない → 後屈で腰の一か所が折れる

クライアントに当てはまるか、まず3つ確認

確認すること	はい
前屈で腰だけが丸まる?	☐
後ろに反ると一か所だけ痛む?	☐
長く座ると腰が張る?	☐

原口の臨床メモ

腰の張りは「動いていない場所の代わりに頑張っている」サインのことが多い。動かない場所を探すのが評価です。

④ 骨盤・腰部:どう見るか

テスト	開始姿勢	測り方	見るポイント
立位の骨盤	立位、横と後ろから	前傾・後傾の傾向、左右の高さ	静止の形は参考程度。動作と合わせて見る
前屈・後屈	立位、ゆっくり	動きが止まる位置、痛みが出る位置	一か所で折れる → その上下の可動性を確認
SLR(下肢伸展挙上)	背臥位、膝を伸ばしたまま脚を上げる	角度(°)、張り・痛みの場所	左右差。しびれが脚に走る場合は神経の関与も考え、無理をしない
股関節の屈曲	背臥位、膝を胸へ	骨盤が後ろに倒れ始める位置	股関節と腰の動きの分担を見る

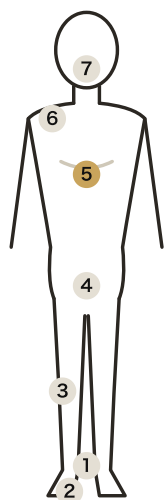
解釈のヒント

「骨盤の歪み」は説明しやすい言葉ですが、それだけで終わると再評価ができません。**どの動きで、どこが止まるか**に言い換えて記録します。

よくある誤り

- ・ 「骨盤の歪み」で説明を終える
- ・ しびれや脱力があるのに、施術を続ける(レッドフラッグを確認)
- ・ 前屈の指先の位置だけで柔軟性を判断する

⑤ 胸郭・呼吸:なぜ見るか



胸郭は、呼吸を行う場所であり、肩甲骨が動くための土台でもあります。呼吸の仕方は、首肩の緊張とも関わります。

押さえない解剖

- **横隔膜**:主な呼吸筋。腹部と胸の動きを生む
- **肋骨と胸椎**:呼吸でわずかに動き、回旋にも関わる
- **呼吸補助筋**:斜角筋・胸鎖乳突筋など。強い呼吸のときに働く
- **前鋸筋**:肩甲骨を胸郭に沿わせる

よくある代償の流れ

- 胸椎が丸まって動かない → 腕を上げるときに腰を反らせて代償
- 安静でも胸の上部ばかりが動く → 首肩の筋が休みにくい可能性

クライアントに当てはまるか、まず3つ確認

確認すること	はい
安静時に肩が上下して呼吸している?	☐
ひねる動きに左右差がある?	☐
深呼吸で肋骨の下が広がらない?	☐

原口の臨床メモ

呼吸は1日2万回以上くり返す動作。ここが変わると、首肩の「休み方」が変わります。

⑤ 胸郭・呼吸:どう見るか

テスト	開始姿勢	測り方	見るポイント
安静呼吸の観察	座位または背臥位で1分休んだあと	胸と腹のどちらがどれくらい動くか	胸の上部ばかりが動く/肩が上下する
呼吸数	安静座位で1分休んでから、1分間数える	回/分	安静でも多い場合は、体調の確認も行う
胸郭の回旋	座位、腕を胸の前で組んで左右にひねる	回旋の角度と左右差	片側だけ少ない→胸椎・肋骨の動きを確認
胸郭の拡張	手を肋骨の下部に当てて深呼吸	左右の広がり	広がりの少ない側を記録

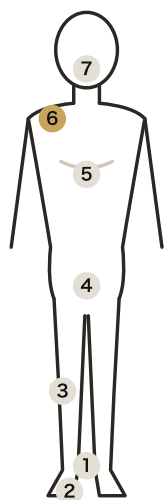
解釈のヒント

胸の動きが大きいからといって、すぐに「補助筋が働き続けている」とは言えません。呼吸数、首肩の力み、息苦しさなどと合わせて判断します。息苦しさや胸の痛みがある場合は医療機関へ。

よくある誤り

- 呼吸を評価項目に入れていない
- 運動直後に呼吸数を測る
- 腹式呼吸だけを「正解」として教え込む

⑥ 肩甲骨・頸部:なぜ見るか



肩甲骨は、腕の動きと頭の位置を支える土台です。首肩のこりは、肩甲骨や胸郭が動かないことで起こっている場合もあります。

押さえない解剖

- **肩甲骨上腕リズム**:腕を上げるとき、肩甲骨も上方へ回旋して一緒に動く
- **僧帽筋・前鋸筋**:肩甲骨の上方回旋を協力して生む
- **肩甲挙筋**:肩をすくめる動きに関わり、緊張しやすい
- **頸椎**:上部は回旋、下部は曲げ伸ばしの割合が大きい

よくある代償の流れ

- 肩甲骨が動かない → 上腕だけで挙げて肩がすくむ
- 頭が前に出る → 首の後ろの筋が支え続ける

クライアントに当てはまるか、まず3つ確認

確認すること	はい
腕を上げると肩がすくむ?	☐
振り向く動きに左右差がある?	☐
話しているときも肩が上がっている?	☐

原口の臨床メモ

首肩は「最後に頑張っている場所」。緩めるのは最後で、まず土台と胸郭を確かめます。

⑥ 肩甲帯・頸部:どう見るか

テスト	開始姿勢	測り方	見るポイント
腕の挙上	立位または座位、前から上へ	角度、肩がすくむ位置、痛みの位置	肩甲骨の動き出しが遅い/すくむ
肩甲骨の動き	後方から挙上と下ろす動きを観察	浮き、左右差、動きのなめらかさ	下ろすときの動きも見る
頸部の回旋・側屈	座位、ゆっくり	角度と左右差、つまり・痛みの場所	しびれや強い痛みが出る場合は中止
肩をすくめる癖	座位で話しながら観察	無意識に肩が上がっているか	呼吸や作業姿勢との関係を確認

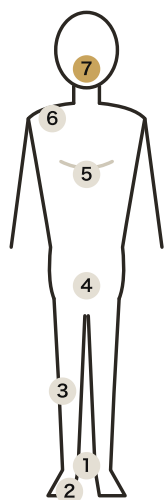
解釈のヒント

首肩だけを緩めて終わると、土台が変わらずに戻りやすくなります。胸郭(⑤)と、地面からの土台(①②)を合わせて確認します。

よくある誤り

- 首肩だけ緩めて終わる
- 手のしびれや脱力があるのに、首を強く動かす
- 挙上の角度だけを見て、肩甲骨の動きを見ない

⑦ 顎・頭部:なぜ見るか



顎は、頭の位置・舌・呼吸と関わります。首肩の相談でも、顎の使い方を確認すると手がかりが見つかることがあります。

押さえない解剖

- 顎関節:回転と前へのすべりを組み合わせて口を開ける
- 咬筋・側頭筋:食いしばりで緊張しやすい
- 舌の位置:安静時の舌の位置は、頭や首の姿勢とも関わる
- 後頭下筋群:頭の位置の微調整に関わる

よくある代償の流れ

- 食いしばり → 側頭部・首の緊張が抜けにくい
- 頭が前に出る → 顎の位置や開き方にも影響する

クライアントに当てはまるか、まず3つ確認

確認すること	はい
口を開けると顎が左右にずれる?	☐
日中や睡眠中に食いしばっている?	☐
舌の位置を聞かれて答えられない?	☐

原口の臨床メモ

顎は見落とされやすい場所です。首肩の相談で顎を確認すると、評価の地図が一段細かくなります。

⑦ 顎・頭部:どう見るか

テスト	開始姿勢	測り方	見るポイント
開口の動き	座位、ゆっくり大きく開ける	下顎がまっすぐ下りるか、ずれる方向	ずれる・音が鳴る → 記録。痛みがあれば歯科へ
開口量	座位、最大開口	上下の前歯の間の距離 (mm)	前回と比べる。痛みや引っかかりがあれば歯科へ
舌の位置	安静時に「舌はどこにありますか」と聞く	上あご/下の歯の裏/分らない	呼吸や頭の位置との関係を確認
食いしばりの確認	問診+頬・こめかみの触診	日中・睡眠中の自覚、筋の張り	歯科での相談をすすめることもある

解釈のヒント

顎の痛み、開口障害、強い音や引っかかりが続く場合は、歯科・口腔外科の領域です。施術者は「気づいてつなぐ」役割を大切にします。

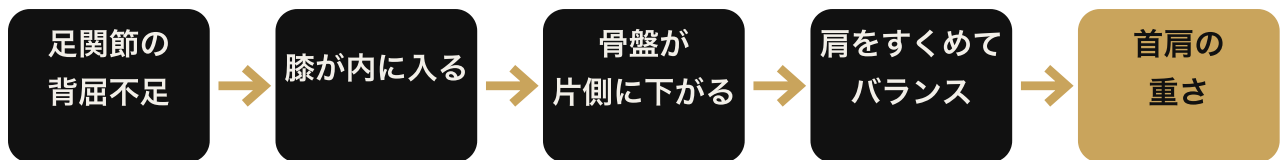
よくある誤り

- 顎は歯科の領域、と評価から完全に外す
- 痛みや開口障害のある顎を、自己判断で強く動かす
- 舌や呼吸と切り離して顎だけを見る

よくある連鎖パターン

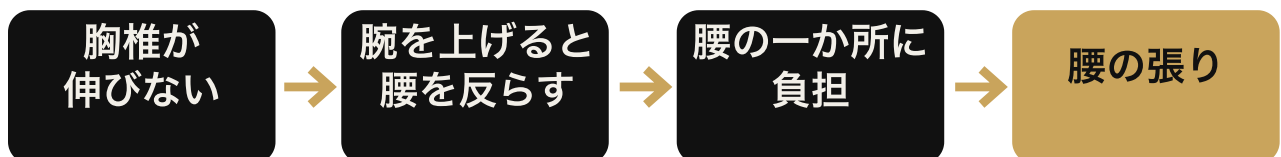
部位ごとの所見は、つなげて見ると意味が出てきます。以下は現場でよく見かける流れの例です。必ずしもこの順で起こるわけではなく、仮説の候補として使ってください。

パターンA:足元から首肩へ



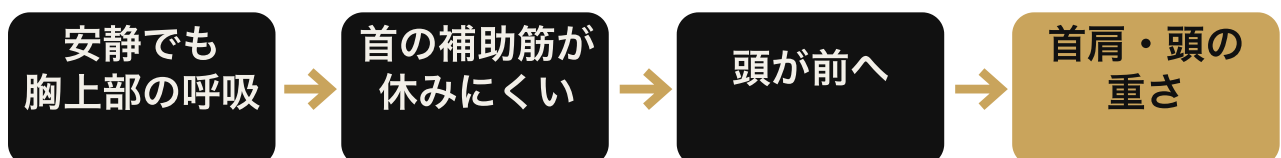
土台の不安定さを、上の部位が肩代わりしている可能性

パターンB:胸郭から腰へ



動かない場所の代わりに、動きすぎる場所が出てくる

パターンC:呼吸から首へ



呼吸の観察は、首肩の相談で見落とされやすい

使い方

主訴の部位(連鎖の最後)から、左へさかのぼるように評価します。途中の所見がそろえば仮説の候補として強くなり、そろわなければ別のパターンを考えます。

仮説の立て方

評価で集めた所見から、「なぜ、ここに負担が集まっているのか」の仮説を立てます。仮説は1～2個に絞るのがコツです。

ステップ	やること	例
1 主訴を確認	痛み・重さが出る動作と、その強さ	腕を上げると右肩が重い NRS 6
2 所見を並べる	△×がついた所見をすべて書き出す	右Knee to Wall 6cm、右骨盤↓、右肩すくみ
3 つながりを探す	25ページの連鎖を参考に、所見をつなぐ	足元→骨盤→肩のパターンAに近い
4 仮説を1～2個に	「〇〇が△△の代わりに働いている」の形で書く	右足部の安定不足を、右肩のすくみで補っている
5 確かめ方を決める	再評価で使うテストを先に決める	Knee to Wall、片脚立ち、挙上時の重さ

良い仮説の条件

- **確かめられる**:再評価のテストで変化を見られる
- **小さい**:一度に1～2個。全部を一度に変えようとしない
- **捨てられる**:変化がなければ、こだわらずに次の候補へ

避けたい言い方

「〇〇が原因です」と言い切ることは避けます。評価で分かるのは「可能性」です。「今日の評価では、〇〇が関わっている可能性が高そうなので、まずそこから確かめましょう」と伝えます。

記入例1:施術しても戻る肩こり

※以下は流れを示すための架空の記入例です。効果を示すデータではありません。

項目	記入
主訴	右の首肩の重さ。夕方に強い。NRS 7(デスクワーク後)
問診	3年前に右足首を捻挫。デスクワーク1日8時間。運動はほぼなし
姿勢	頭部前方。右肩がやや下がる。立位で左荷重
スクリーニング	スクワット△(右踵が浮く)/片脚立ち△(右で骨盤↓)/挙上△(右で肩すくみ)
部位別	①右Knee to Wall 6cm・左10cm ⑤安静呼吸で胸上部優位、呼吸数22回/分(安静座位) ⑥右挙上150°で肩すくみ

仮説

右足部・足関節の安定不足を、右肩をすくめてバランスをとることで補っている可能性。呼吸の浅さも首肩の緊張を強めているかもしれない。

選択(アプローチ)

① 右足関節・足部へのアプローチ → 一度再評価 ② 呼吸の練習 → もう一度再評価(何が効いたか分かるよう、分けて確かめる)

再評価(同じ条件で)

Knee to Wall 右6→9cm/挙上時の重さ NRS 7→3/呼吸数 22→16回/分。首肩に直接触れずに変化 → 仮説を継続して検証(1回の変化で因果関係は確定しない)。次回も同じテストから始める。

※呼吸数は、運動直後ではなく安静座位で1分休んでから測定。

記入例2:階段で膝の内側が痛い

※以下は流れを示すための架空の記入例です。効果を示すデータではありません。

項目	記入
主訴	右膝の内側の痛み。階段を下りるとき NRS 5
問診	半年前から。外傷なし。腫れ・熱感なし。週2回ウォーキング
姿勢	右膝がやや内向き。右の足部アーチが低め
スクリーニング	スクワット△(右膝が内へ)/片脚立ち△(右で骨盤↓、足部の揺れ大)
部位別	①右背屈の制限(膝屈曲位でも少ない) ②右ナビキュラードロップ大 ③右股関節内旋が少ない、片脚スクワットで右膝が内へ

仮説

足部の安定と股関節の動きが不足し、着地のたびに膝の内側に負担が集まっている可能性。

選択(アプローチ)

① 足部・足関節へのアプローチ → 再評価 ② 股関節へのアプローチと片脚立ちの練習 → 再評価

再評価(同じ条件で)

片脚スクワットで膝の向きが改善、階段を下りるときの痛み NRS 5→2。痛みが残る・腫れが出る場合は整形外科の受診をすすめる。

※腫れ・熱感・ロッキング(膝が動かなくなる)がある場合は、評価の前に医療機関へ。

記入例3:前屈で腰が張る

※以下は流れを示すための架空の記入例です。効果を示すデータではありません。

項目	記入
主訴	前かがみで腰の下の方が張る。洗顔時 NRS 4
問診	1年前から。しびれなし。排尿・排便の異常なし。座り仕事
姿勢	骨盤やや後傾、胸椎の丸まりが強い
スクリーニング	前屈△(腰だけが丸まり、股関節が曲がらない)/後屈△(胸が開かない)
部位別	④SLR 右55°・左60°、股関節屈曲で早くから骨盤が後傾 ⑤胸郭の回旋 左右とも少ない

仮説

股関節の屈曲が不足し、前屈の動きを腰が肩代わりしている可能性。胸椎の動きの少なさも関わっているかもしれない。

選択(アプローチ)

① 股関節の後面へのアプローチ → 再評価 ② 胸椎の動きを出す → 再評価

再評価(同じ条件で)

前屈で股関節から曲がる動きが増え、洗顔姿勢の張り NRS 4→1。SLR 右55→65°。

※しびれ・脱力・排尿排便の異常が出た場合は、すぐに医療機関へ(5ページ参照)。

再評価とクライアントへの説明

結果	考え方	次の一手
変化あり	仮説の候補として残す(因果関係はまだ確定しない)	次回も同じテストから始め、変化が続くか確かめる
少し変化	アプローチの量・方法が合っていない可能性	方法を変えるか、もう1つの仮説を試す
変化なし	仮説が違う可能性。失敗ではなく情報	連鎖をさかのぼり、別の部位を評価する
悪化	負荷が強すぎる/対象外の可能性	中止し、レッドフラッグを再確認。必要なら医療機関へ

説明の型: 見せる → つなげる → 約束しない

- 1. 見せる:** 「最初は壁から6cmでしたが、今は9cmまで膝がつかます」と、数字や動作で変化を一緒に確かめる
- 2. つなげる:** 「足首が安定すると、肩でバランスをとる必要が減るので、肩の重さも変わった可能性があります」
- 3. 約束しない:** 「これで治ります」とは言わない。「次回も同じテストで確かめていきましょう」

セルフケアの渡し方

- 1つだけ渡す(多いと続かない)
- 評価で変化が出た動きを選ぶ
- 「痛みが出たらやめる」「やってみてどうだったか次回教えてください」をセットで伝える

評価シート(印刷用)

項目	記入	
日付・氏名		
主訴(動作・NRS)		
レッドフラッグ	☐ なし ☐ あり → 医療機関へ	
問診メモ		
姿勢(前・横・後ろ)		
スクリーニング	前屈 ○△× / 後屈 ○△× / スクワット ○△× / 片脚立ち ○△× / 挙上 ○△×	
部位	所見(数値・左右差)	再評価
① 足関節		
② 足部・歩行		
③ 膝・股関節		
④ 骨盤・腰部		
⑤ 胸郭・呼吸		
⑥ 肩甲帯・頸部		
⑦ 顎・頭部		
仮説	選択	再評価の結果

※このページを印刷するか、スマホで写真に撮って書き込んでお使いください。

特典動画と次のステップ

特典動画:下肢編 手技セミナーの一部を公開



スマホで読み取る

https://youtu.be/P_EifGnl7Uk

実際のセミナーで行っている下肢の手技を、映像で確認できます。

次のステップ

	内容
7日間講座	このLINEで、明日から7日間「評価の順番」を1日1テーマずつお届けします
無料コミュニティ	162名が参加するLINEグループ。週1回、現場で使える視点と記事を共有しています
ZERO MEMBERS	毎月の勉強会(Zoom)・アーカイブ・会員限定記事・症例相談。評価から手技まで深く学べます
零式セミナー	解剖・評価・手技を、対面で体験しながら学ぶセミナーを各地で開催しています

身体を、零へ。

足す前に、戻る。身体は本来完成している — 評価して、選んで、確かめる。その積み重ねが、あなたの臨床を変えていきます。

— 零-ZERO- 原口慶篤